

Cours de Résidanat

Sujet : 14

Cancer du sein

Première partie : 38 QCM

1. Concernant le drainage lymphatique superficiel du sein, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Il draine l'ensemble de la glande mammaire.
- B. Il draine la peau de la région mammaire.
- C. Le drainage aboutit principalement aux ganglions axillaires.
- D. Les collecteurs lymphatiques de ce réseau cheminent à la surface du derme.
- E. De petits canaux issus de ce réseau superficiel plongent en profondeur vers un plexus sus-aréolaire.

2. Concernant le drainage lymphatique du sein, lesquelles des propositions suivantes sont correctes ?

- A. Les quadrants inférieurs se drainent vers la région sus-claviculaire
- B. Les quadrants internes se drainent vers les ganglions mammaires internes
- C. Tous les quadrants se drainent principalement vers les ganglions axillaires
- D. Les quadrants supérieurs se drainent vers les ganglions sous-claviculaires
- E. Le drainage lymphatique progresse généralement sans saut de relais ganglionnaire

3. Le premier relais ganglionnaire du sein est le plus souvent :

- A. Le ganglion sentinelle de la chaîne mammaire interne
- B. Un ganglion axillaire
- C. Un ganglion sus-claviculaire
- D. Un ganglion cervical bas
- E. Un ganglion médiastinal haut

4. Quelle forme histologique est la plus fréquente parmi les cancers infiltrants du sein ?

- A. Carcinome lobulaire infiltrant
- B. Carcinome colloïde
- C. Carcinome canalaire infiltrant
- D. Carcinome médullaire
- E. La maladie de Paget

5. Le carcinome lobulaire infiltrant se distingue du canalaire notamment par:

- A. Sa tendance à former des masses bien limitées
- B. Sa prédominance chez la femme jeune
- C. Sa bilatéralité fréquente
- D. Sa régression rapide sous traitement hormonal
- E. Des cellules réalisant l'aspect en file indienne

6. Une tumeur du sein

- A. Est multifocale en cas de présence de deux foyers dans deux quadrants différents.
- B. Est multicentrique en cas de présence de deux foyers dans deux quadrants différents.
- C. Est multicentrique en cas de présence de deux foyers situés à une distance supérieure à 3 cm les uns des autres.
- D. Est bilatérale dans 25% des cas.
- E. Peut-être retro-mamelonnaire .

7. Quelles sont les caractéristiques du carcinome canalaire in situ ?

- A. Présente un risque métastatique élevé
- B. Est de moins bon pronostic si associé à une comédonécrose .
- C. Peut-être multicentrique
- D. Souvent associé à des micro calcifications
- E. Non accessible au dépistage

8. La maladie de Paget :

- A. Est une lésion eczématiforme du mamelon et de la plaque aréolo-mamelonnaire .
- B. C'est lésion souvent bénigne.
- C. Peut se traduire par des macro calcifications.
- D. Est souvent bilatérale.
- E. Ne nécessite pas un prélèvement histologique.

9. Quel marqueur biologique reflète le taux de prolifération tumorale dans le cancer du sein ?

- A. Le statut HER2
- B. L'indice Ki67
- C. Le taux de CA15-3
- D. Le taux de récepteurs aux œstrogènes
- E. Le taux de récepteurs aux œstrogènes

10. A propos de l'extension du cancer du sein :

- A. Peut-être loco régionale
- B. Se fait uniquement par voie lymphatique
- C. Peut-être précoce
- D. Le site de métastase à distance le plus fréquent est l'os
- E. Conditionne le pronostic

11. Concernant l'extension lymphatique du cancer du sein:

- A. Le relais supérieur de la chaîne axillaire est le premier envahi.
- B. La fréquence d'envahissement ganglionnaire augmente avec la taille de la tumeur
- C. Plus le nombre de ganglions envahis est important, plus le pronostic est mauvais
- D. L'atteinte de la chaîne sus-claviculaire est de mauvais pronostic
- E. L'atteinte de la chaîne mammaire interne est plus fréquente si la tumeur est centrale ou externe

12. Parmi les facteurs qui prédisposent au cancer du sein, on cite :

- A. Puberté précoce
- B. ménopause tardive
- C. Absence d'allaitement
- D. Multiparité
- E. Première grossesse précoce à l'âge de 17 ans

13. Quel est le principal facteur de risque génétique de cancer du sein ?

- A. Mutation BRCA1
- B. Mutation p16
- C. Mutation APC
- D. Mutation VHL
- E. Mutation P 50

14. Parmi les signes cliniques évocateurs d'un cancer du sein ,on cite:

- A. Un nodule mal limité
- B. Rétraction récente du mamelon
- C. La mastodynie
- D. Présence d'adénopathie axillaire
- E. La taille du nodule de 2 cm

15. Mme R vous consulte pour un nodule mammaire, la mammographie trouve une masse de contours non circonscrites, spiculés, classée ACR 5 qui signifie:

- A. La nécessité de compléter par IRM.
- B. Une anomalie bénigne ne nécessitant ni surveillance ni examen complémentaire.
- C. Une anomalie fortement évocatrice de cancer.
- D. Une anomalie bénigne pour laquelle une surveillance à court terme est indiquée.
- E. Une anomalie qui nécessite une vérification histologique.

16. Les micro calcifications suspectes sur une mammographie sont :

- A. Grossières et diffuses
- B. Rondes, régulières
- C. Groupées en foyers, de forme irrégulière
- D. Linéaires, uniques
- E. Volumineuses

17. L'échographie mammaire

- A. Est proposé uniquement si la mammographie ne montre pas une anomalie.
- B. Précise le caractère liquidien, solide ou mixte de la tumeur.
- C. Peut montrer une atténuation postérieure en cas d'une lésion mammaire suspecte.
- D. Est intéressante surtout chez la femme jeune.
- E. N'est pas un examen indispensable s'il s'agit d'une lésion mammaire bénigne.

18. L'IRM mammaire :

- A. Est demandée de 1ère intention.
- B. Est indiqué en cas d'un carcinome lobulaire invasif.
- C. Est indiquée dans le dépistage de cancer du sein en cas de mutation BRCA
- D. Est indiquée pour chercher une lésion mammaire en présence d'une adénopathie axillaire sans anomalie écho-mammographique
- E. Est indiquée en cas de suspicion de récurrence.

19. Une patiente connue porteuse d'un carcinome infiltrant de type non spécifique du sein droit classé cT1N0, le bilan d'extension repose sur :

- A. L'examen clinique
- B. Une échographie abdominale et une radiographie de thorax
- C. Comporte généralement une scintigraphie osseuse et un scanner cérébral
- D. Repose sur un dosage de CA 15-3 pour évaluer l'agressivité de la tumeur.
- E. Comporte une TDM thoraco-abdomino-pelvien

20. Parmi les éléments de pronostic d'un cancer du sein, on cite:

- A. La taille tumorale.
- B. L'âge de la patiente.
- C. L'atteinte ganglionnaire.
- D. Le siège de la tumeur.
- E. L'extension locale.

21. Les facteurs histologiques de mauvais pronostic du cancer du sein sont :

- A. Le grade histo pronostique SBR II ou III.
- B. L'absence d'emboles lymphatiques, vasculaires péri-tumoraux ou de nécrose.
- C. L'absence de récepteurs hormonaux.
- D. La présence de surexpression de l'oncogène Her2neu.
- E. Un index de prolifération tumorale Ki67 <20%.

22. La surexpression de la protéine HER2/neu dans un cancer du sein :

- A. Indique un bon pronostic et ne nécessite pas de traitement ciblé
- B. Est une cible thérapeutique pour des anticorps monoclonaux comme le Trastuzumab
- C. Est toujours associée à une absence de récepteurs hormonaux
- D. N'a pas d'impact sur la prise en charge thérapeutique
- E. Est caractéristique du carcinome lobulaire in situ

23. Concernant les récepteurs hormonaux dans les cancers du sein, quelle(s) proposition(s) est (sont) correcte(s)

- A. Ils sont absents si la femme est ménopausée.
- B. Leur expression oriente la décision d'une hormonothérapie.
- C. L'absence de récepteurs hormonaux est un facteur de bon pronostic.
- D. On évalue habituellement seulement les récepteurs aux œstrogènes
- E. Est une indication à un traitement par herceptine.

24. Une tumeur maligne du sein de 2 cm du quadrant supéro-externe fixée par rapport aux deux plans avec une adénopathie homolatérale dure fixée de 2cm, les éléments de mauvais pronostic sont:

- A. Sa localisation
- B. L'existence d'adénopathie
- C. Le caractère fixe de l'adénopathie
- D. La fixité par rapport aux deux plan
- E. La taille

25. Parmi les propositions suivantes concernant le cancer du sein triple négatif, laquelle(s) est (sont) exacte(s) ?

- A. Il est plus fréquent chez les femmes jeunes
- B. Il est caractérisé par l'absence des récepteurs hormonaux
- C. Il a un meilleur pronostic que les autres types
- D. Il est caractérisé par la surexpression de Her 2neu
- E. Il évolue généralement plus lentement que les autres cancers du sein

26. Parmi ces affirmations concernant les phénotypes moléculaires du cancer du sein, laquelle est correcte ?

- A. Les cancers triple négatifs ont un meilleur pronostic que les luminal A
- B. Le phénotype HER2 enrichi est toujours associé à une absence de traitement ciblé
- C. Les cancers luminal B ont un pronostic intermédiaire entre luminal A et triple négatif
- D. Les cancers luminal A ont le plus mauvais pronostic
- E. Tous les cancers du sein ont le même pronostic indépendamment du phénotype moléculaire

27. Parmi les éléments suivants, lesquels influencent la prise en charge thérapeutique d'un cancer du sein ?

- A. La localisation de la tumeur
- B. La classification moléculaire
- C. Le type histologique
- D. Le taux de CA15 3
- E. La classification TNM

28. Devant une tumeur du sein classée T1N0M0, la prise en charge thérapeutique peut inclure :

- A. Une chirurgie conservatrice si possible
- B. Une hormonothérapie en cas de RH+
- C. Un traitement systématique par chimiothérapie
- D. Une radiothérapie après tumorectomie
- E. Une surveillance simple

29. Concernant les indications de la zonectomie, quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s) ?

- A. Elle est contre-indiquée dans les cancers du sein multifocaux
- B. Elle est indiquée en cas de tumeur infra clinique ou de micro calcifications
- C. Elle est indiquée dans les tumeurs avec envahissement cutané étendu
- D. Elle peut être proposée après chimiothérapie néoadjuvante
- E. Elle est contre-indiquée chez les patientes âgées de plus de 70 ans

30. La chimiothérapie néoadjuvante

- A. Dépend du statut immuno-histochimique de la tumeur
- B. Est indiquée si tumeur retro mamlonnaire
- C. Le volume tumoral n'intervient pas dans la décision
- D. Est indiquée en cas de formes débutantes
- E. Est toujours est indiquée dans les stades T1 N0 M0

31. Chez une patiente RH+ HER2- avec tumeur de 2 cm, grade II, 1 ganglion envahi, quel est l'intérêt d'un test génomique ?

- A. Aucun intérêt, la chimiothérapie est systématique
- B. Aucun intérêt, car la radiothérapie est toujours nécessaire
- C. Évaluer le bénéfice potentiel de la chimiothérapie adjuvante
- D. Décider de la chirurgie mammaire
- E. Diagnostiquer un cancer triple négatif

32. La radiothérapie locorégionale est systématique si

- A. Curage axillaire négatif
- B. Mutation BRCA détectée
- C. Cancer du sein chez une femme jeune < 40 ans
- D. Traitement conservateur
- E. Tumeur de 3 cm triple négatif

33. Le traitement des formes localement avancées du cancer du sein repose essentiellement sur :

- A. La chirurgie seule
- B. La chimiothérapie néo-adjuvante seule
- C. Hormonothérapie + Thérapie ciblée
- D. L'association chimiothérapie néo-adjuvante + chirurgie + radiothérapie
- E. L'association radiothérapie + chirurgie

34. Le calendrier habituel du suivi post-thérapeutique du cancer du sein comprend :

- A. Se fait tous les 6 mois pendant les 3 premiers ans puis de façon annuelle à vie.
- B. Se fait tous les 3 mois pendant les 2 premiers ans puis tous les 6 mois entre 3 et 5 ans puis de façon annuelle à vie.
- C. Comporte une mammographie 6 mois après la fin du traitement puis 1x/an.
- D. Comporte une TDM thoraco abdominale chaque 2 ans
- E. La scintigraphie osseuse est systématique chaque cinq ans

35. Le suivi post thérapeutique du cancer du sein:

- A. Le dosage du marqueur tumoral CA15-3 est indiqué chez les patientes métastatiques
- B. Comporte une échographie pelvienne endovaginale pour les femmes sous Tamoxifène
- C. Rentre dans le cadre de la prévention primaire.
- D. Augmente le taux de survie générale de la population atteinte de cancer du sein
- E. N'est systématique que pour les formes à haut potentiel de récurrence

36. Le dépistage précoce du cancer du sein

- A. Repose essentiellement sur l'autopalpation des seins
- B. N'a pas un impact important pour diminuer les formes évoluées
- C. Indique la réalisation obligatoire d'une IRM mammaire annuelle dans les formes génétiques à partir de l'âge de 30 ans
- D. Permet de prévenir la survenue d'un cancer du sein
- E. Est indiqué uniquement chez la femme ayant des facteurs de risque.

37. Parmi les examens complémentaires suivants, les quels sont utilisés dans le dépistage des cancers du sein?

- A. L'IRM mammaire.
- B. L'autopalpation des seins.
- C. La mammographie.
- D. Le dosage sérique de la CA 15.3
- E. L'échographie mammaire.

38. Concernant les moyens de prévention du cancer du sein:

- A. L'allaitement maternel pour une durée de 2 ans est un facteur protecteur
- B. Eviter les grossesses avant 30 ans
- C. Le traitement hormonal substitutif est un facteur protecteur
- D. Alimentation riche en acides gras polyinsaturés
- E. Garder une activité sportive régulière.

Deuxième partie : 18 QCM dans le cadre 4 cas cliniques

Cas clinique numéro 1 :

Mme Z., âgée de 60 ans, consulte pour la découverte récente d'un nodule au sein gauche, découvert à l'auto-palpation il y a une semaine.

Antécédents :

- **Pas d'antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein**
- **Ménopausée à l'âge de 55 ans**
- **Quatre grossesses menées à terme avec première grossesse à l'âge de 36 ans.**
- **Pas de traitement hormonal substitutif**
- **Tabagique**

Examen clinique :

- **Masse palpable de 1,8 cm, située au quadrant inféro-interne du sein gauche**
- **Consistance ferme, indolore, mobile par rapport aux 2 plans , sans signes inflammatoires ou de rétraction cutanée**
- **Pas de masse palpable au sein droit**
- **Pas d'écoulement mammelonnaire**
- **Aires ganglionnaires axillaires libres**

1. Cette patiente présente comme facteurs de risque du cancer du sein:

- A. L'âge
- B. L'absence d'antécédents de néoplasie dans la famille
- C. La ménopause à l'âge de 55 ans
- D. La multiparité
- E. Le tabac

2. Quelle est votre conduite de première intention:

- A. Il s'agit très probablement d'un nodule d'allure bénigne qui nécessite une surveillance clinique à six mois.
- B. Une IRM mammaire est indispensable
- C. Une exérèse du nodule est nécessaire.
- D. Une echo-mammographie en première intention
- E. Une microbiopsie première est obligatoire

- 3. L'exploration a conclu à un carcinome lobulaire infiltrant de grade SBRIII. Le bilan d'extension comporte**
- A. Une IRM mammaire
 - B. Un scanner thoraco abdominal pelvien
 - C. Une scintigraphie osseuse
 - D. Un dosage CA 15-3
 - E. Une Echo-cœur
- 4. La lésion est classée cliniquement:**
- A. cT1N1M0
 - B. cT1N0Mx
 - C. pT1N0M0
 - D. T2N0M0
 - E. T2N0Mx
- 5. L'immunohistochimie a montré: RH+,Ki 67 à 35% avec surexpression Her 2 neu ++. Les éléments de mauvais pronostic sont:**
- A. RH positifs
 - B. Ki 67 à 35%
 - C. Le type histologique
 - D. Surexpression Her 2 neu
 - E. La taille tumorale

Cas clinique numéro 2 :

Mme H., 36 ans, G2P2, sans antécédents médicaux notables, consulte pour un nodule palpable au niveau du sein gauche, découvert à l'auto-palpation depuis 1 mois.

À l'examen : masse de 3 cm au niveau du QSE du sein gauche, dure, mal limitée, mobile par apport au deux plans. Il n'y a pas d'adénopathie axillaire palpable

Une echomammographie est réalisée, objectivant un nodule classé ACR 5.

1. Quelle est l'étape suivante:

- A. Une macrobiopsie
- B. Une microbiopsie echo guidée
- C. Une zonectomie
- D. Une microbiopsie
- E. Une exérèse large

2. L'exploration a conclu à un carcinome infiltrant non spécifique de grade SBR III, RH négatifs, HER2neu +. Il s'agit d'un carcinome:

- A. Luminal A
- B. Luminal B
- C. Triple négatif
- D. Her 2 surexprimé
- E. Non classé

3. Le bilan d'extension est négatif. Quelle est votre conduite à tenir:

- A. Une zonectomie
- B. Une chimiothérapie néoadjuvante
- C. Une mastectomie avec curage axillaire
- D. Une radiothérapie première
- E. Une tumorectomie avec technique du ganglion sentinelle.

Cas clinique numéro 3:

Madame H.S., 36 ans, consulte pour une augmentation de volume du sein droit, avec rougeur, chaleur et douleur évoluant depuis 2 semaines.

Elle a été traitée par amoxicilline-acide clavulanique sans amélioration.

Pas d'antécédents familiaux de cancer du sein.

G1P1, accouchement il y a 8 mois, allaitement interrompu depuis 4 mois.

L'examen clinique : montre une masse mal limitée au quadrant supéro-externe du sein droit, avec une peau rouge et tendue et présence d'une rétraction du mamelon récente . Pas d'écoulement. Présence d'une adénopathie axillaire homolatérale palpable mobile.

1. Parmi les diagnostics suivants, lesquels peuvent être évoqués ?

- A. Abscess du sein
- B. Maladie de Paget
- C. Tumeur phyllode
- D. Cancer inflammatoire du sein
- E. Galactophorite

2. Concernant l'examen clinique, quels sont les éléments qui orientent vers une étiologie maligne ?

- A. Masse fixe et mal limitée
- B. Rougeur du sein
- C. L'absence d'un écoulement galactophorique
- D. Rétraction récente du mamelon
- E. La présence d'adénopathie

L'écho-mammographie: masse dense à limites flous occupant la moitié supérieure du sein droit associée à un épaissement du revêtement cutané correspondant en échographie à une formation à double composante charnue et kystique avec ADP homolatérale de 2 cm.

3. Quelle est votre conduite à tenir?

- A. Une cytoponction de la composante kystique du nodule du sein
- B. Une microbiopsie du nodule du sein s'impose en urgence
- C. Une microbiopsie de l'ADP axillaire s'impose en urgence
- D. Une cytoponction de l'adénopathie
- E. Un scanner thoracique

4. Cette lésion est classée:

- A. T4 a N0M0
- B. T4 bN0M0
- C. T4aN2M0
- D. T4d N1Mx
- E. T4d N2 M0

L'examen anatomopathologique: conclue à un carcinome infiltrant de type non spécifique, SBR III, Récepteurs hormonaux positifs, Her 2 neu à 2 + et ki 67 à 70 %

Bilan d'extension est négatif.

5. Le facteur clinique de mauvais pronostic chez cette patiente est:

- A. La nulliparité
- B. Le sous type triple négatif
- C. Her 2 neu sur exprimé
- D. Ki 67 à 70 %
- E. L'âge jeune de la patiente

Cas clinique numéro 4:

A l'occasion d'octobre Rose, madame Mabrouka, 40 ans, mère de 3 enfants, consulte pour un examen des seins.

Elle n'a aucun symptôme mammaire, mais mentionne un antécédent familial de cancer du sein chez sa mère, diagnostiqué à l'âge de 49 ans.

À l'examen clinique : pas de nodule, pas d'écoulement mamelonnaire, pas d'adénopathie axillaire.

1. Quelle est votre conduite à tenir?

- A. Une mammographie de dépistage tous les 2 ans à partir de 45 ans
- B. Faire une mammographie de dépistage tous les 2 ans
- C. Faire une échographie mammaire tous les ans à partir de 40 ans
- D. IRM mammaire annuelle vu les ATCD familiaux de cancer du sein
- E. Une écho-mammographie de dépistage annuel

Les explorations ont conclu à un foyer de micro-calcifications du QSE du sein gauche classé ACR4.

2. Quelle est la signification de cette anomalie ?

- A. Seins strictement normaux
- B. Elimine une lésion maligne
- C. Probablement bénigne qui nécessite une surveillance
- D. Cancer prouvé histologiquement
- E. Suspecte de malignité

3. Cette lésion nécessite:

- A. Une exérèse large
- B. Une mastectomie
- C. Une microbiopsie échoguidée
- D. Une zonectomie après repérage
- E. Une surveillance radiologique

L'examen anatomopathologique a conclu à un carcinome infiltrant de type non spécifique de 1 cm, grade SBR III récepteurs hormonaux positifs, Her2Neu positifs ++ et ki67 à 65%.

4. Les éléments de mauvais pronostic sont:

- A. La taille tumorale de 01 cm
- B. Le type histologique
- C. Le grade SBRIII
- D. Les récepteurs hormonaux positifs
- E. Her 2 Neu positif

5. Quel serait la conduite à tenir de deuxième intention préconisée ?

- A. Une mastectomie
- B. Une radiothérapie locorégionale
- C. Chimiothérapie adjuvante
- D. Curage axillaire ou ganglion sentinelle
- E. Hormonothérapie

Bonne Chance